

FASE 1: PREADMISIÓN

FASE 2: PRE OPERATORIO

PRE OPERATORIO INMEDIATO

1. Realizar evaluación preanestésica.
2. Confirmar ingesta de premedicación (Akynzeo 300 mg + pregabalina 75 mg + paracetamol 1 g 4 h antes de la cirugía. Registrar.
3. Resolver dudas.
4. Firmar Consentimiento Anestésico.

PREPARACIÓN DE PABELLÓN

1. Monitorización no invasiva.
2. Calentador de aire forzado manta cuerpo superior.
5. Termómetro nasofaríngeo (**no esofágico**) fijo en piel/spot on.
6. Tromboprofilaxis mae + cni.
7. Sonda de calibración cuando se utilice.

FASE 2: INTRAOPERATORIO

ANESTESIA

Inducción:

1. Anestesia baja en opiodes individualizada según paciente.
2. Normotermia.
3. Normoglicemia y normovolemia.
4. Antibiótico profilaxis según norma institucional.
5. Propofol 2,5mg/kg EV.
6. Esmeron 0,5mg/kg EV.
7. Dexametasona 8mg – Ketorolaco 60mg EV (Paracetamol no administrar si tomo premedicación).
8. Omeprazol 40 mg EV/día.
9. Metadona 5-10mg SC.
10. Metoclopramida 10mg. EV.
11. Metamizol 2gr EV.

Mantención:

1. Sevoflurano/desflurano. Registrar ET gases.
2. Vasopresores para mantener PAM (registrar).
3. Volumen EV hasta 1000ml total.
4. Evitar sobrehidratación.
5. Recordar Infiltración local por cirujano con Chirocaina en puertos laparoscópicos.

Despertar:

1. Comprobar correcta reversión de bloqueo neuromuscular. Registrar.
2. Neostigmina o Sugammadex según TOF.
3. Semisentado.
4. O2 por mascarilla necesario para saturación mayor a 93% para traslado.

** Registros obligatorios:

- volumen EV administrado,
- Pérdidas hemáticas estimadas
- temperatura de egreso de pabellón
- TOF al término
- ET gases

FASE 3: POSTOPERATORIO INMEDIATO

1. Régimen cero.
2. Semisentado Cabeza 30°
3. O2 por mascarilla necesario para saturación mayor a 93%.
4. Instalar CPAP en usuarios crónicos.
5. Reposo relativo
6. Levantar con kinesiólogo 60 minutos después del llegar a Recuperación
7. Suero glucosalino 80ml/hr
8. Metadona 3 mg EV SOS en Recuperación si EVA > 3
9. Parecoxib 40mg EV SOS por una vez
10. Droperidol 0,625 mg EV SOS náuseas/vómitos
11. Ketorolaco 10 mg VO cada 8 h
12. Metamizol 1 g EV cada 8 h SOS
13. Paracetamol 1gr c/6hr. oral considerando horario de premedicación.
14. Enoxaparina 40 mg/día ** confirmar hora de administración con cirujano, al término de la operación.
15. Medias anti embólicas - compresión neumática intermitente hasta deambular
16. Kinesioterapia respiratoria y motora

ERAS es una vía de cuidado perioperatorio multidisciplinario diseñada para lograr la recuperación precoz de pacientes sometidos a cirugía mayor. Comprende todas las fases de cuidado de cada paciente, introduciendo mejores prácticas basadas en evidencia y centradas en la persona.

ENCARE
ENHANCING ERAS

FASE 1: PREADMISIÓN

CONSULTA PREANESTÉSICA

1. Evaluación preanestésica en consulta usando plantilla Word
2. Registrar peso, talla, consumo OH y tabaco en unidades
3. Revisión de exámenes
4. Revisión de patologías compensadas
5. Score P-POSSUM fase pre operatoria
6. Reforzar indicaciones de ayuno y toma de carga de carbohidratos (proporcionados por enfermera ERAS)

FASE 2: 2-PRE OPERATORIO

PRE OPERATORIO INMEDIATO

1. Revisar evaluación preanestésica de consulta
2. Copiar datos en PMD evaluación preanestésica del episodio quirúrgico
3. Resolver dudas
4. Firmar Consentimiento Anestésico

PREPARACIÓN DE PABELLÓN

1. Posicionador pigazzi
2. Monitorización no invasiva
3. Calentador de aire forzado manta cuerpo superior
5. Termómetro esofágico / nasofaríngeo/ spot on
6. Bis / sedline
7. Trombopprofilaxis mae + cni
8. Catéter peridural t8 -t 10
9. Sonda foley
11. Sonda orogástrica, retirar al término

FASE 2: INTRAOPERATORIO

ANESTESIA

Inducción:

1. Fentanilo hasta 5 ug/kg
2. TIVA/Precedex a discreción de anestesiólogo.
3. PROFILAXIS ANTIBIOTICA: CEFAZOLINA + METRONIDAZOL SEGUN NORMA CUA
4. Profilaxis PONV con 2 antieméticos: dexametasona, metoclopramida. Ondasetrón solo para pacientes con antecedentes PONV y para rescate
5. Analgesia multimodal: Ketorolaco / parecoxib/ ketoprofeno + paracetamol 1 g + metamizol 2 g

Mantención:

1. Sevoflurano / desflurano según profundidad anestésica: hasta 1.0 MAC
2. No usar opiáceos de larga duración
3. Vasopresores para mantener PAM (registrar)
4. Volumen total EV 1500-2000 ML
5. Evitar sobrehidratación
6. Bloqueo neuromuscular profundo, monitorizar TOF y registrar
7. PCA peridural: bolo bupivacaina 0,25% 10-20 ml, 30 min antes de término de la cirugía. Registrar nivel de inserción de catéter.

Edución:

1. Registrar sangramiento estimado
2. Balance hídrico en hoja de anestesia
3. Comprobar correcta reversión de bloqueo neuromuscular, registrar
4. Eventual uso de Sugammadex
5. Registro mínimo de menor temperatura y la de egreso de pabellón
6. Ingresar paciente a Unidad de Dolor

FASE 3: POSTOPERATORIO INMEDIATO

1. Régimen 0 por 4 horas, luego hídrico solo agua máximo 500 ml/día. Luego Nutrición sigue protocolo
2. Reposo relativo
3. PCA peridural 5-5-20
4. Levantar con kinesiólogo 90 minutos después de llegar a Recuperación
5. Suero premezcla 80 ml/hora
6. Ondansetrón 4 mg EV c/ 8 horas SOS
7. Ketorolaco / parecoxib / Ketoprofeno por horario
8. Paracetamol 1 gr EV c/6 horas
9. Metamizol 1 g EV cada 8 horas
10. Omeprazol 40 mg EV/día
11. Enoxaparina 40 mg/día **confirmar hora de administración con cirujano, al término de la operación
12. Medias anti embólicas - compresión neumática intermitente hasta deambular
13. Kinesioterapia respiratoria y motora

ERAS es una vía de cuidado perioperatorio multidisciplinario diseñada para lograr la recuperación precoz de pacientes sometidos a cirugía mayor. Comprende todas las fases de cuidado de cada paciente, introduciendo mejores prácticas basadas en evidencia y centradas en la persona.

ENCARE
ENHANCING ERAS